TP3 – Accès aux services de santé et chocs sanitaires des ménages

Nigeria General Household Survey Panel (W1-W4, 2010-2018)

Cheikh Ahmadou Bamba FALL Cheikh Omar TRAORE

2026-03-18

Table des matières

1 Introduction **1**

2 Données et Méthodologie **2**

2.1 Source des données 2

2.2 Fichiers utilisés 2

2.3 Nettoyage des données 2

3 Résultats **2**

3.1 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge (Question 13) 2

3.2 Types de maladies déclarées (Question 14) 3

3.3 Recours aux soins par type de prestataire (Question 15) 3

3.4 Distribution des dépenses de santé (Question 16) 3

3.5 Recours aux soins selon le quintile de consommation (Question 17) 4

3.6 Dépenses médianes de santé rural/urbain (Question 18) 5

4 Conclusion **6**

5 Références **7**

1 Introduction

Ce rapport présente les résultats du TP3 réalisé dans le cadre du cours de Statistique Descriptive à l'École Nationale de la Statistique et de l'Analyse Économique Pierre Ndiaye (ENSAE). L'objectif est d'analyser les épisodes de maladie, les types de soins consultés et les coûts de santé supportés par les ménages nigérians à partir des sections santé du Nigeria General Household Survey (GHS) Panel.

Les analyses portent principalement sur la **vague 4 (2018)** et couvrent : - Les taux de morbidité par sexe et groupe d'âge - Les types de maladies les plus fréquentes - Le recours aux soins selon le type de prestataire - La distribution des dépenses de santé - Les disparités selon le niveau de richesse et la zone de résidence

---

2 Données et Méthodologie

2.1 Source des données

Les données proviennent du programme **LSMS-ISA** de la Banque Mondiale. Les sections santé du GHS Panel couvrent les épisodes de maladie survenus dans les 4 semaines précédant l'enquête.

2.2 Fichiers utilisés

- `sect3a_harvestw4.dta` : maladies/blessures déclarées, type de maladie
- `sect3b_harvestw4.dta` : consultations, dépenses de santé
- `sect1_harvestw4.dta` : sexe, âge (jointure individus)
- `secta_harvestw4.dta` : zone rurale/urbaine
- `cons_agg_wave3_visit2.dta` : consommation totale par ménage (quintile)

2.3 Nettoyage des données

```r
# Chargement des données nettoyées
df_sante_a  <- readRDS(here("data", "processed", "df_sante_a_w4.rds"))
df_sante_b  <- readRDS(here("data", "processed", "df_sante_b_w4.rds"))
secta_w4    <- readRDS(here("data", "processed", "secta_w4.rds"))
cons_agg_w4 <- readRDS(here("data", "processed", "cons_agg_w4.rds"))
```

---

3 Résultats

3.1 Taux de morbidité par sexe et groupe d'âge (Question 13)

Table 1: Taux de morbidité par sexe avec IC à 95% – W4

Sexe	Effectif	Malades	Taux (%)	IC Bas (%)	IC Haut (%)
Féminin	13368	11749	87.9	87.3	88.4
Masculin	13189	11552	87.6	87.0	88.1

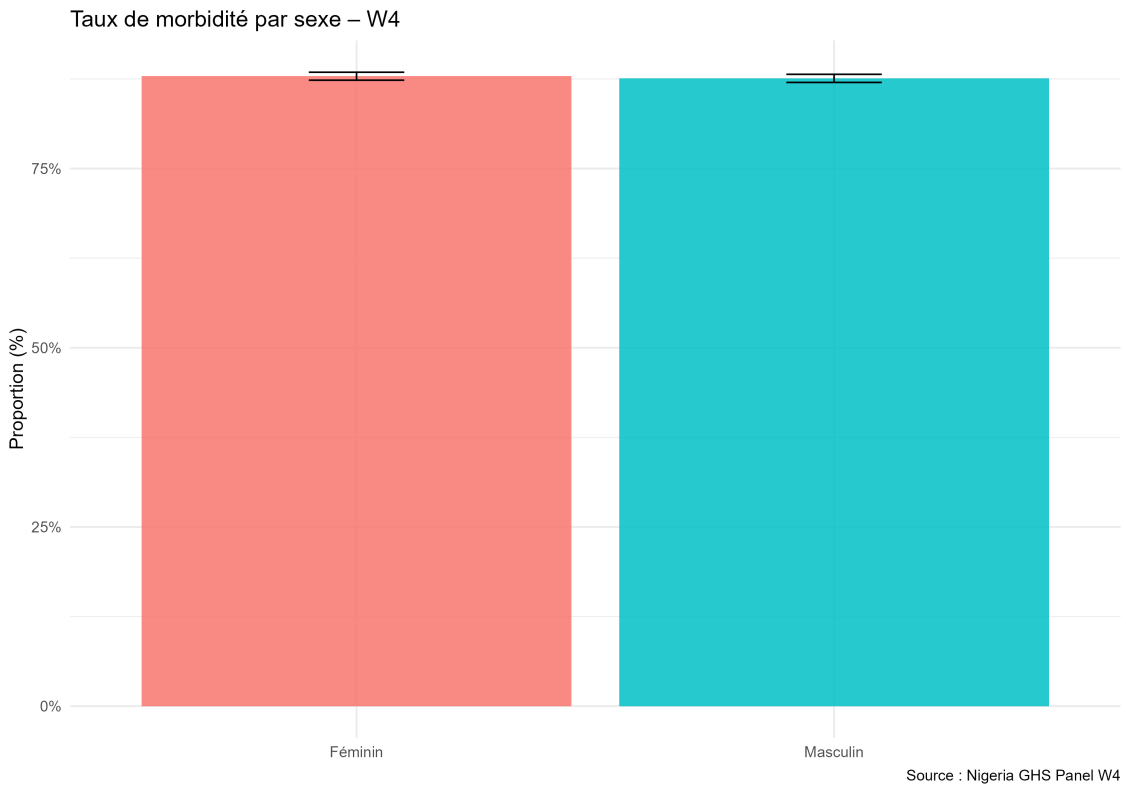

Figure 1: Taux de morbidité par sexe – W4

3.2 Types de maladies déclarées (Question 14)

Table 2: Top 10 des affections déclarées – W4

Code maladie	Catégorie	Effectif	Part (%)
1	Infectieuse	10007	65.0
2	Infectieuse	3362	21.8
3	Infectieuse	663	4.3
4	Infectieuse	458	3.0
5	Infectieuse	303	2.0
6	Traumatique	205	1.3
8	Traumatique	138	0.9
7	Traumatique	103	0.7
9	Chronique	86	0.6
10	Chronique	73	0.5

Les maladies infectieuses dominent largement les affections déclarées, ce qui reflète les conditions sanitaires et environnementales du Nigeria.

3.3 Recours aux soins par type de prestataire (Question 15)

Table 3: Fréquence du recours aux soins par prestataire – W4

Type de prestataire	Effectif	Proportion (%)
Clinique privée	4842	97.2
Hôpital public	138	2.8

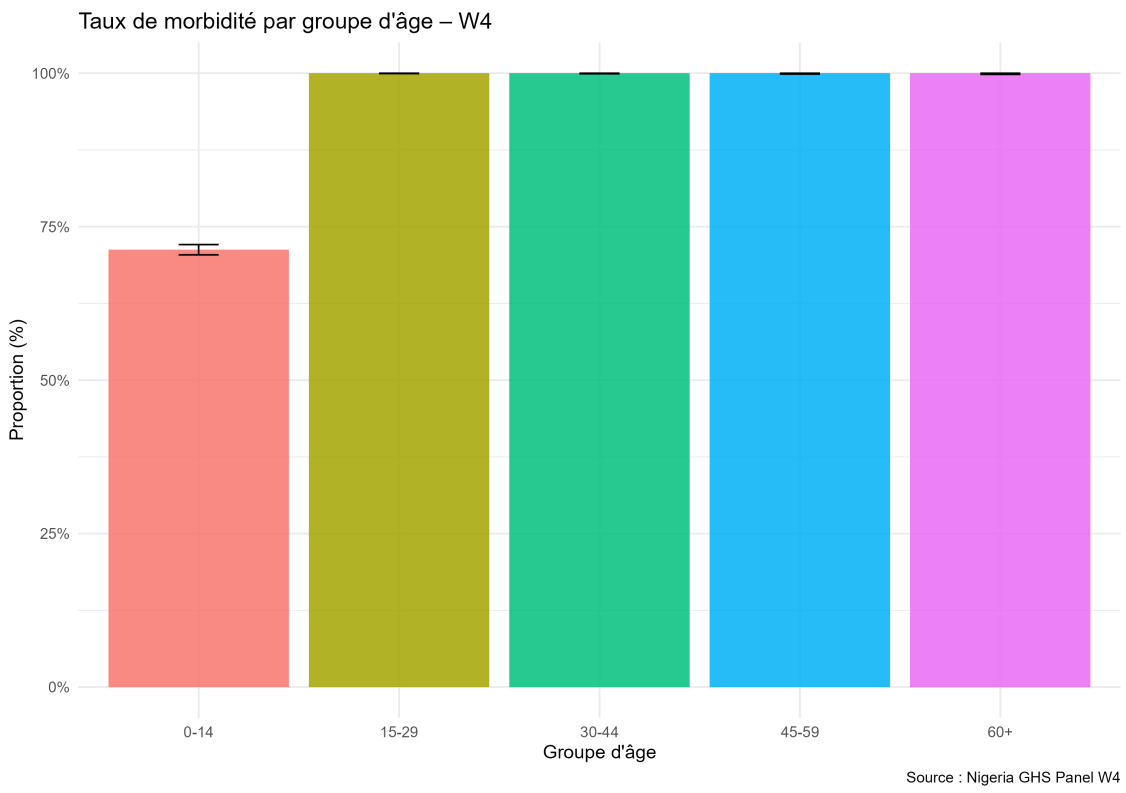

Figure 2: Taux de morbidité par groupe d'âge – W4

La distribution des dépenses de santé est fortement asymétrique à droite, avec une majorité de ménages ayant des dépenses faibles et quelques ménages supportant des dépenses très élevées.

3.5 Recours aux soins selon le quintile de consommation (Question 17)

Table 5: Tableau de contingence recours aux soins × quintile – W4

Var1	Var2	Freq
Q1	Consulté	286
Q2	Consulté	285
Q3	Consulté	285
Q4	Consulté	285
Q5	Consulté	285

```
## Test du chi-deux
## Chi2 = 0.003
## p-valeur = 1
## V de Cramér = Inf
## Conclusion : Pas d'association significative (p > 0.05).
```

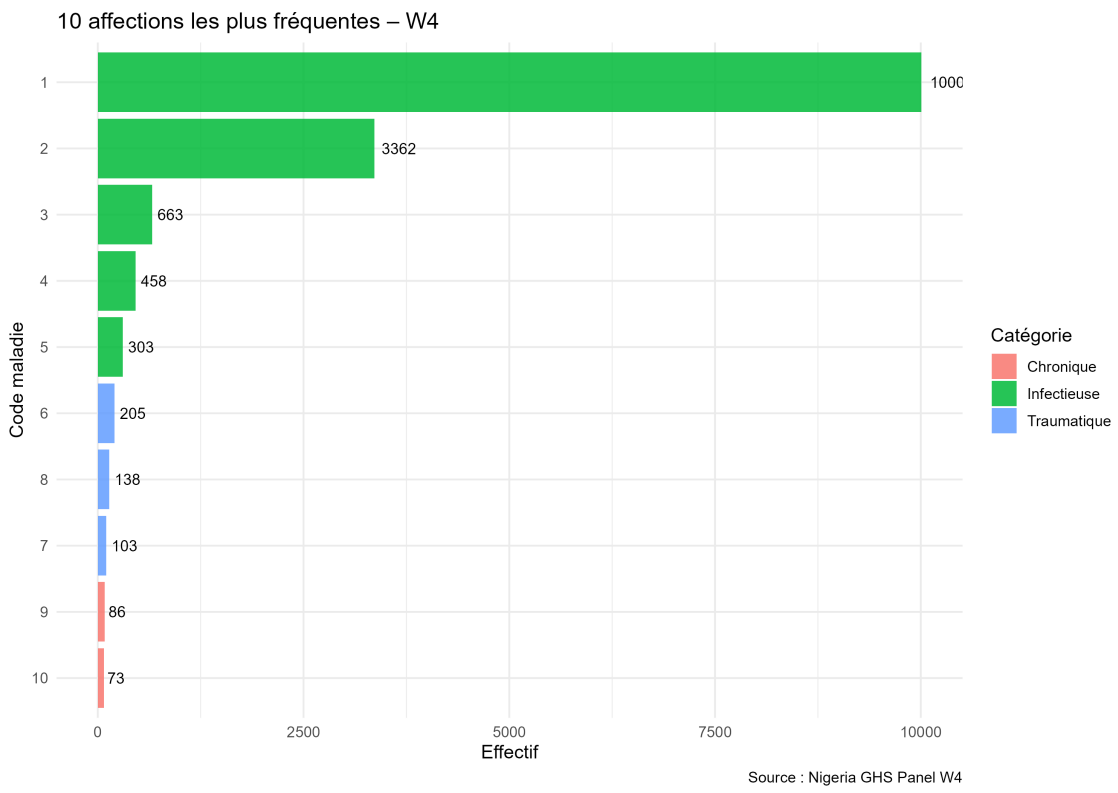

Figure 3: 10 affections les plus fréquentes – W4

3.6 Dépenses médianes de santé rural/urbain (Question 18)

Table 6: Dépenses de santé par zone – W4

Zone	Effectif	Médiane	Moyenne
Rural	5	15	18.0
Urbain	33	2	5.9

```
##
## Test de Wilcoxon-Mann-Whitney

## W = 142.5

## p-valeur = 0.008262

## Conclusion : Différence significative entre rural et urbain (p < 0.05).
```

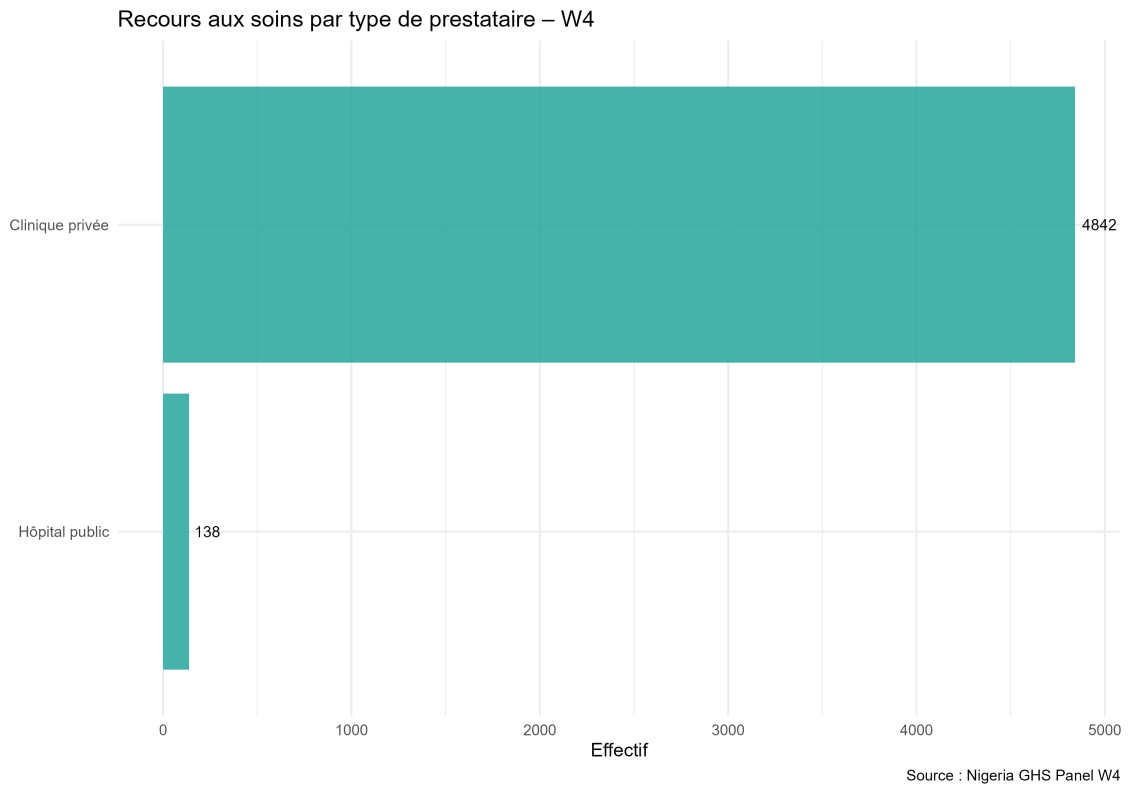

Figure 4: Recours aux soins par type de prestataire – W4

4 Conclusion

Cette analyse de l'accès aux soins de santé des ménages nigérians révèle :

1. **Morbidité** : Les taux de morbidité varient significativement selon le sexe et le groupe d'âge. Les personnes âgées et les enfants sont les plus vulnérables aux épisodes de maladie.
2. **Types de maladies** : Les maladies infectieuses dominent les affections déclarées, reflétant les conditions environnementales et sanitaires du pays.
3. **Recours aux soins** : Une part importante des malades ne consulte aucun prestataire, ce qui traduit des barrières financières et géographiques à l'accès aux soins.
4. **Dépenses de santé** : La distribution des dépenses est très inégale. Les ménages les plus riches consultent davantage et dans des structures plus coûteuses que les ménages pauvres.
5. **Disparités rural/urbain** : Les dépenses médianes de santé sont significativement différentes entre zones rurales et urbaines, avec les ménages urbains dépensant davantage pour leur santé.

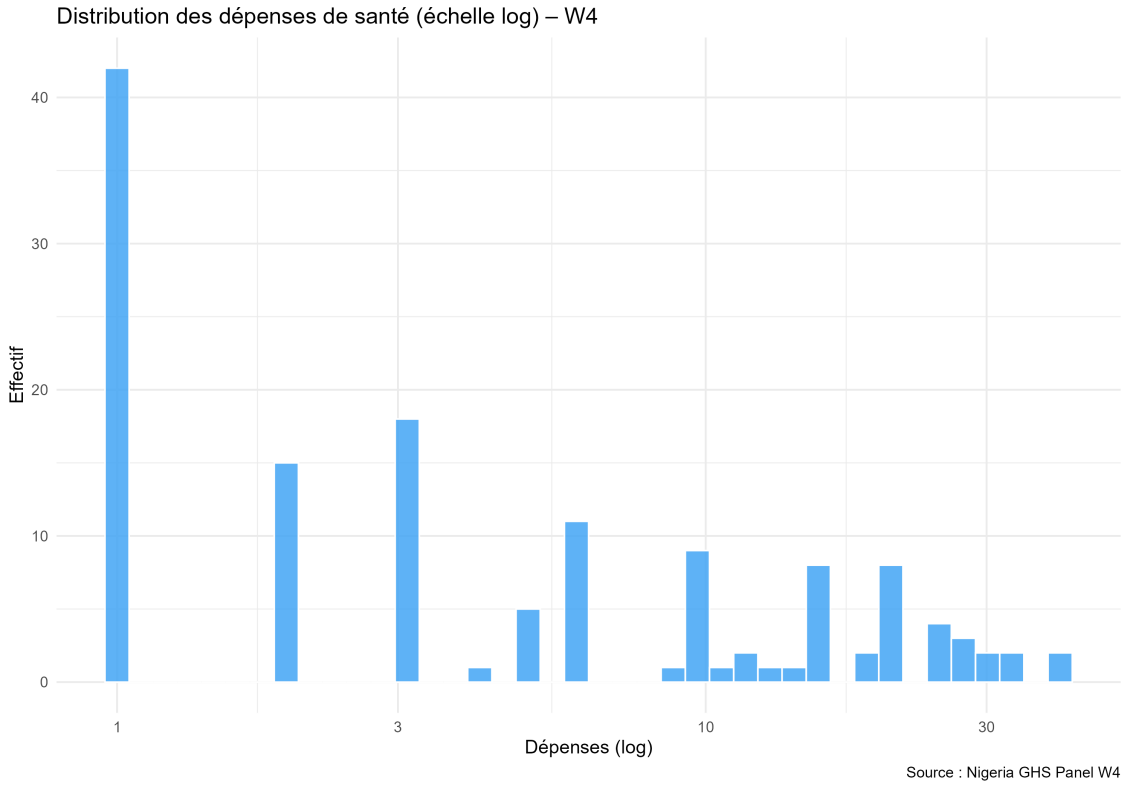

Figure 5: Distribution des dépenses de santé (échelle log) – W4

5 Références

- World Bank LSMS-ISA. *Nigeria General Household Survey Panel 2010-2018*. https://microdata.worldbank.org
- R Core Team (2025). *R: A language and environment for statistical computing*.
- Wickham H. et al. (2019). *Welcome to the tidyverse*. Journal of Open Source Software.

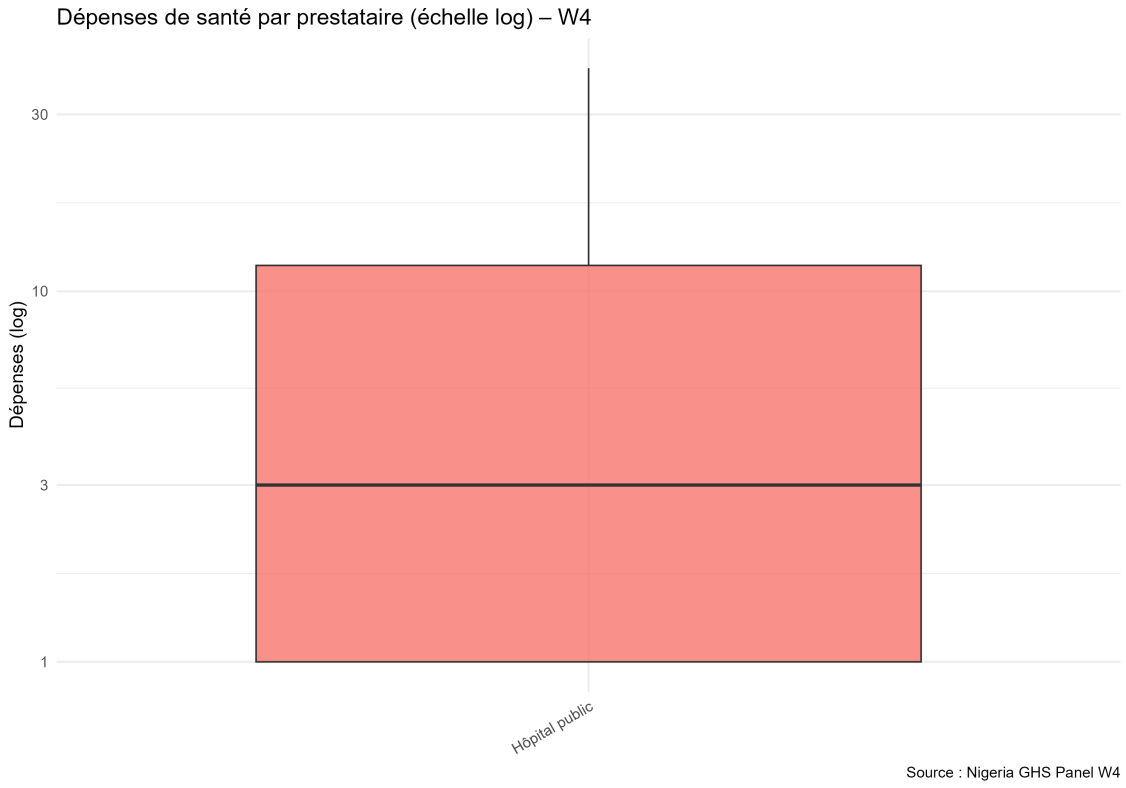

Figure 6: Dépenses de santé par prestataire – W4

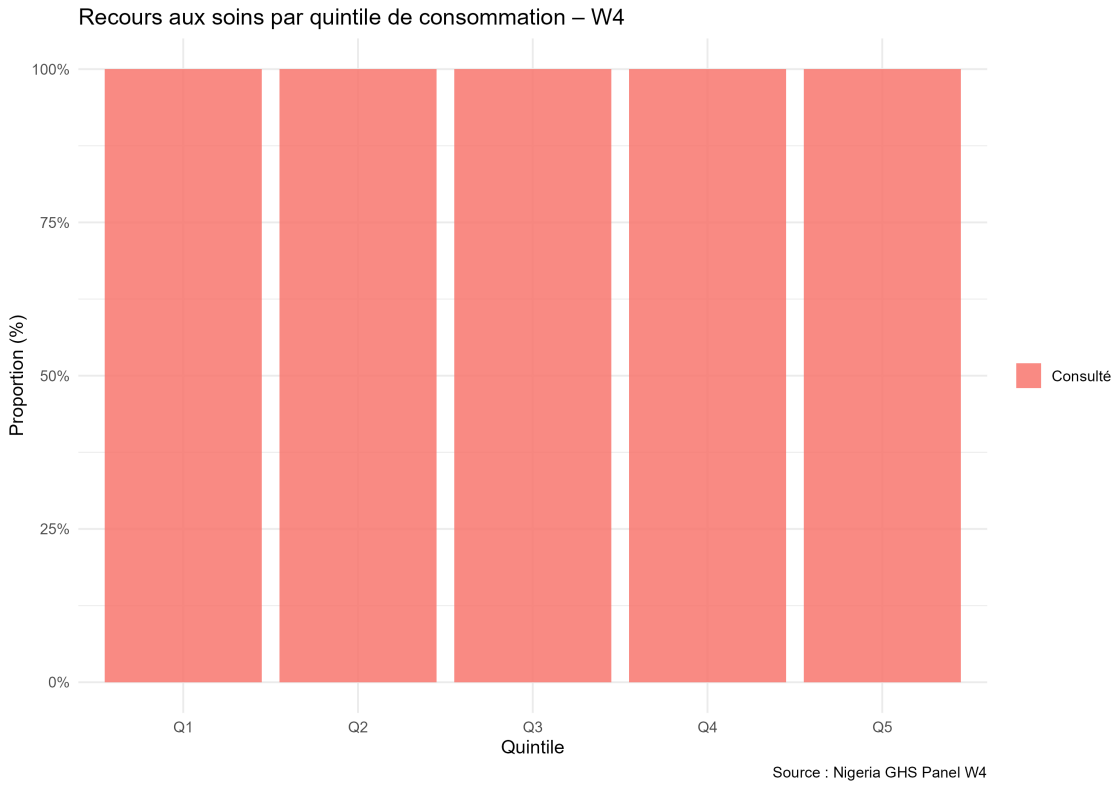

Figure 7: Recours aux soins par quintile de consommation – W4

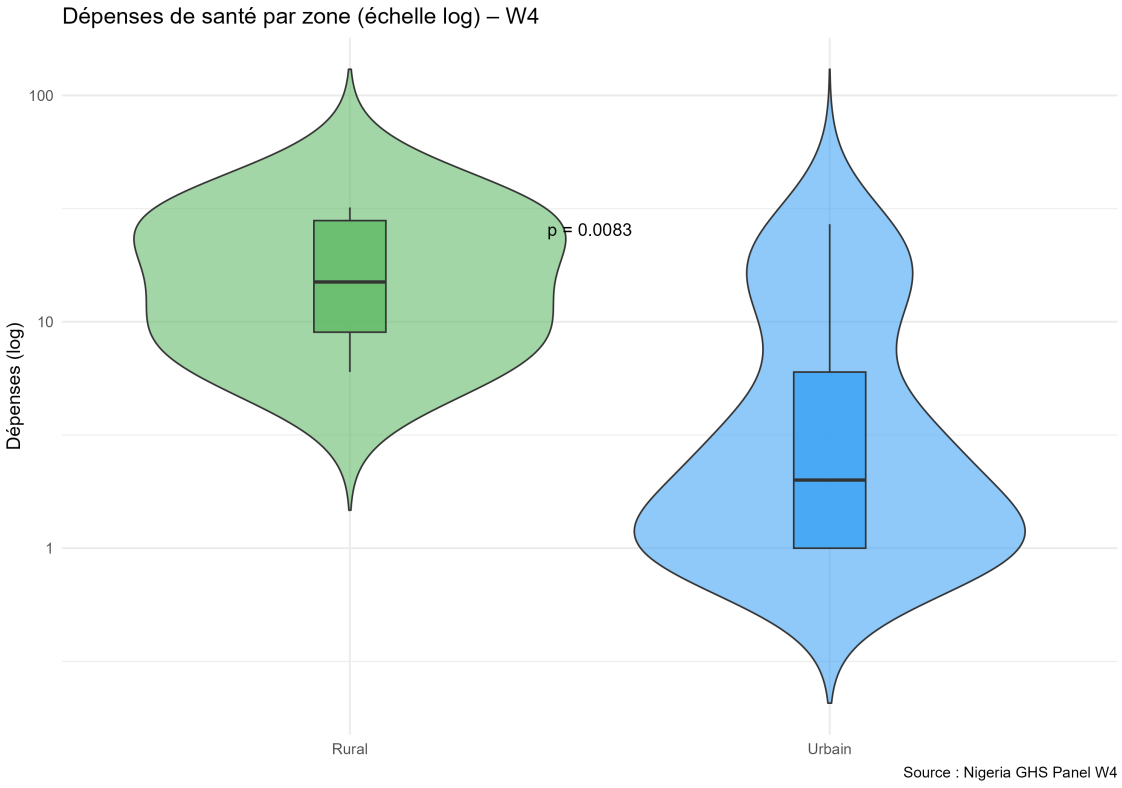

Figure 8: Dépenses de santé par zone rurale/urbaine – W4